

Lignes directrices sur la prévention, le diagnostic et le traitement de l'infertilité

Résumé des recommandations



Introduction

L'infertilité est une affection du système reproducteur masculin ou féminin définie par l'impossibilité d'aboutir à une grossesse après 12 mois ou plus de rapports sexuels non protégés réguliers.

À l'échelle mondiale, environ une personne sur six en âge de procréer aura des problèmes d'infertilité au cours de sa vie. Les individus et les couples ont le droit de décider du nombre d'enfants qu'ils souhaitent, du moment auquel les avoir et de l'écart entre eux.

Toutefois, il existe un écart entre la fécondité souhaitée et la fécondité réelle dans de nombreux pays, ce qui limite la capacité des personnes à atteindre leurs objectifs en matière de procréation, et ce pour diverses raisons, parmi lesquelles l'infertilité. C'est pourquoi la lutte contre l'infertilité est un élément important pour permettre aux individus et aux couples de réaliser leurs préférences en matière de fécondité.

En agissant au plus vite, les pays pourront répondre aux besoins en matière de services de prévention, de diagnostic et de traitement de l'infertilité et atténuer les nombreuses inégalités liées à la disponibilité, à l'accessibilité, à l'acceptabilité et à la qualité des soins relatifs à la fertilité.

La présente note d'orientation offre un récapitulatif des recommandations relatives à la prévention, au diagnostic et au traitement de l'infertilité figurant dans les *Lignes directrices de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) sur la prévention, le diagnostic et le traitement de l'infertilité (1)*. Elle a pour objet de servir d'outil pour aider les décideurs politiques et toutes les parties prenantes dans le domaine de l'infertilité à comprendre les recommandations formulées dans les lignes directrices et à assumer le rôle qui leur revient en vue de les mettre en œuvre.



Organisation
mondiale de la Santé

human
reproduction
programme
hrp
research for impact
UNDP·UNFPA·UNICEF·WHO·WORLD BANK

Objectif des lignes directrices

Les *Lignes directrices de l'OMS sur la prévention, le diagnostic et le traitement de l'infertilité* visent à améliorer la mise en œuvre d'interventions fondées sur des données factuelles dans le domaine de l'infertilité. La fourniture de services de qualité à l'appui de la planification familiale, y compris des services de prévention, de diagnostic et de traitement de l'infertilité, est l'un des éléments fondamentaux de la santé reproductive. Cependant, l'accès aux soins en matière de fertilité reste un défi dans la plupart des pays. Voir la **figure 1** pour plus d'informations sur le contexte, la charge et l'impact de l'infertilité. On trouvera également des objectifs spécifiques dans l'encadré de droite.

Portée et public cible

Les recommandations formulées dans les lignes directrices portent sur la prévention de l'infertilité, ainsi que sur le diagnostic et le traitement de l'infertilité féminine, masculine ou liée à des facteurs inexplicables. Étant donné qu'il s'agit des premières lignes directrices de l'OMS sur l'infertilité, elles ne couvrent pas tous les aspects liés à l'infertilité et aux soins relatifs à la fertilité. Il est à prévoir que des éditions ultérieures de ces lignes directrices viendront étoffer la portée des recommandations. Les lignes directrices s'adressent à un large éventail de parties prenantes (voir **figure 2**).

Comment ces lignes directrices ont-elles été élaborées ?

Plusieurs revues systématiques ont été effectuées pour répondre à des questions de recherche fondamentales. Les présentes recommandations ont été formulées par un groupe d'élaboration de lignes directrices pluridisciplinaire et diversifié sur le plan régional à l'aide des méthodes détaillées dans le *Manuel de l'OMS pour l'élaboration des lignes directrices, deuxième édition (2)*. Ces recommandations ont fait l'objet d'un examen par les pairs réalisé par un groupe d'experts et d'intervenants externes.



Environ une personne sur six en âge de procréer aura des problèmes d'infertilité au cours de sa vie.

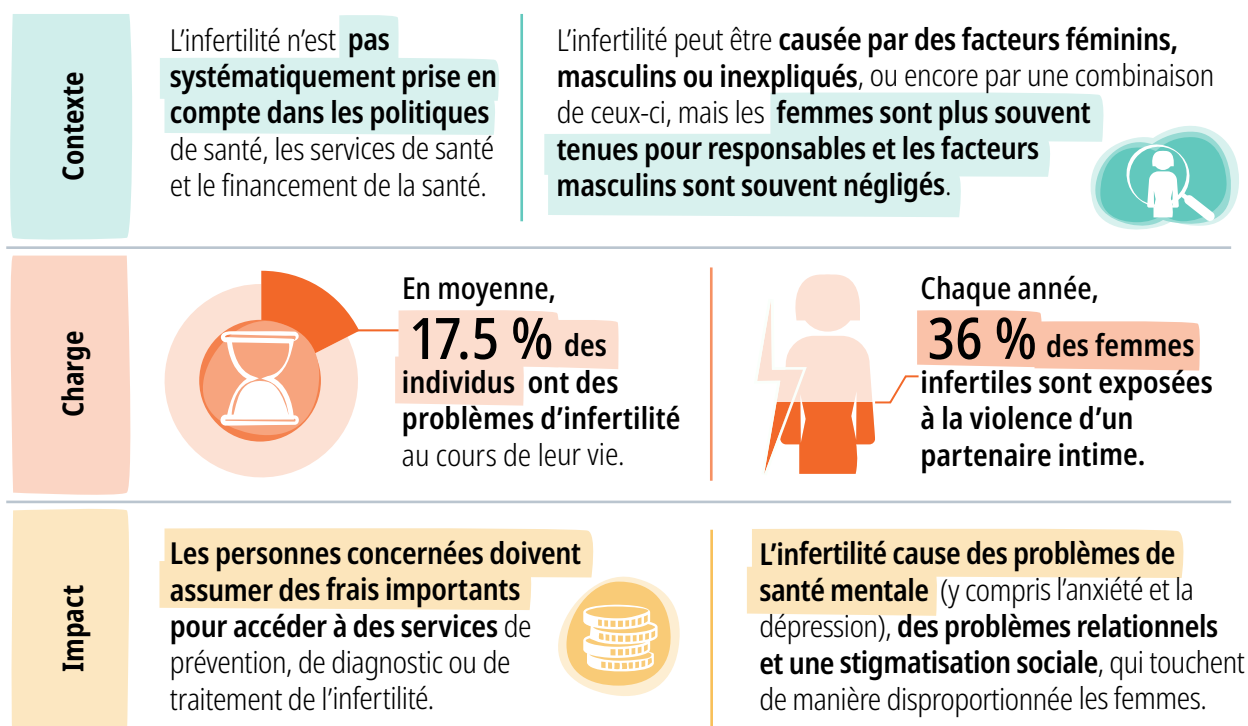


Les objectifs des lignes directrices sont les suivants :

- > Fournir des données factuelles pour étayer les recommandations.
- > Fournir des explications sur tous les facteurs pris en compte pour élaborer les recommandations.
- > Fournir aux pays des informations leur permettant d'adopter, d'adapter ou de mettre à jour des directives nationales.

L'infertilité peut être causée par des facteurs féminins, masculins ou inexplicables, ou encore par une combinaison de ceux-ci, mais les femmes sont plus souvent tenues pour responsables et les facteurs masculins sont souvent négligés ”

Figure 1. Contexte, charge et impact de l'infertilité



La fourniture de services de soins de qualité en matière de fertilité est l'un des éléments fondamentaux de la santé reproductive ”

Figure 2. Les présentes lignes directrices s'adressent notamment au public suivant :



Résumé des recommandations

On trouvera dans le tableau 1 ci-dessous toutes les recommandations figurant dans les lignes directrices, y compris la force de la recommandation et le degré de certitude des données probantes utilisées à l'appui de chaque recommandation. Ces recommandations sont également présentées dans les chapitres correspondants des lignes directrices, et sont accompagnées d'explications concernant les décisions, de diagrammes de décision appropriés pour les diagnostics et d'algorithmes de traitement.

Tableau 1. Résumé des recommandations et des principales orientations

 Approche générale et prise en charge de l'infertilité	
Énoncés de bonnes pratiques sur l'approche générale et la prise en charge de l'infertilité ➔	Pour les hommes et les femmes faisant l'objet d'un diagnostic et d'un traitement pour infertilité, il est recommandé de : ✓ Choisir les tests de diagnostic en fonction des résultats cliniques issus de l'anamnèse et de l'examen physique pour s'assurer que l'évaluation est systématique et rentable. <i>(Énoncé de bonnes pratiques)</i> ✓ Écouter les individus et les couples, respecter leurs préférences, discuter si un soutien psychologique et social ou un soutien par les pairs est nécessaire et, au besoin, fournir un tel soutien ou orienter les patients. <i>(Énoncé de bonnes pratiques)</i> ✓ Fonder les décisions relatives au traitement sur les avantages et les inconvénients, les valeurs et les préférences des patients, la faisabilité, les coûts et la disponibilité des ressources. <i>(Énoncé de bonnes pratiques)</i> ✓ Tenir compte du rapport coût-efficacité du traitement (p. ex., les traitements les moins coûteux, mais efficaces, doivent être administrés en premier). <i>(Énoncé de bonnes pratiques)</i> ✓ Discuter du plan de suivi clinique et de gestion des risques potentiels qui peuvent survenir pendant le traitement de l'infertilité. <i>(Énoncé de bonnes pratiques)</i> ✓ Documenter les résultats des grossesses découlant d'un traitement de l'infertilité. <i>(Énoncé de bonnes pratiques)</i>



Recommandations relatives à la prévention de l'infertilité

Recommandations relatives à la fourniture d'informations sur la fertilité et l'infertilité →

Pour la population générale en âge de procréer, l'OMS recommande de fournir des informations sur la fertilité et l'infertilité en utilisant des stratégies peu coûteuses ou chaque fois que l'occasion se présente. *(Recommandation soumise à conditions, degré de certitude des données probantes très faible)*

Remarques :

- Les stratégies peu coûteuses peuvent consister à distribuer des documents d'information en format numérique ou en format papier lorsque l'occasion se présente dans les écoles, les centres de soins de santé primaires ou les centres de planification familiale (contraception et santé sexuelle).
- Fournir des informations adaptées au contexte et au public local, y compris sur la façon de réduire les facteurs de risque d'infertilité, sur les changements de mode de vie, sur la baisse de la fertilité ou le potentiel de fertilité en fonction de l'âge et sur les consultations médicales en temps opportun, permet d'augmenter la probabilité que les informations soient assimilées et produisent des résultats positifs.

Pour les individus et les couples ayant des problèmes de fertilité, l'OMS suggère de fournir des conseils peu coûteux sur le mode de vie avant et pendant le traitement de l'infertilité. *(Recommandation soumise à conditions, degré de certitude des données probantes faible)*

Remarque :

- Les conseils sur le mode de vie peuvent inclure des conseils sur le changement de régime alimentaire, la consommation d'alcool, le tabagisme, l'activité physique ou la maîtrise du poids.

Recommandation relative à la réduction des risques liés au tabagisme →

L'OMS recommande aux prestataires de soins de santé de prodiguer systématiquement de brefs conseils (entre 30 secondes et 3 minutes par rencontre) à tous les consommateurs de tabac qui se rendent dans un établissement de santé. *(Recommandation forte, degré de certitude des données probantes modéré)*

Remarques :

- Il s'agit d'une recommandation existante de l'OMS pour la population générale qui s'applique également aux personnes et aux couples qui planifient une grossesse, sont en recherche de grossesse ou présentent des problèmes d'infertilité, compte tenu du lien entre l'infertilité et le tabagisme passé ou présent.
- L'évaluation du mode de vie, y compris la consommation du tabac, fait partie de l'anamnèse du patient lors de l'évaluation de l'infertilité chez les individus et les couples.

Recommandation relative à la réduction des risques liés au tabagisme (suite)



- Les brefs conseils sont des conseils ne durant généralement pas plus de quelques minutes prodigués à tous les consommateurs de tabac, généralement au cours d'une consultation de routine ou d'un entretien en tête à tête pour les inciter à renoncer au tabac.
- Les brefs conseils doivent permettre d'informer les individus et les couples : i) que la consommation de tabac, en particulier le tabagisme, est associée à un risque plus élevé d'infertilité ; ii) que le risque d'infertilité liée au tabagisme est plus élevé chez les femmes ; iii) qu'il existe une série d'interventions visant à aider au sevrage tabagique.
- Les brefs conseils doivent inclure les 5 éléments suivants : demander si la personne consomme du tabac ; conseiller à la personne d'essayer d'arrêter de fumer ; évaluer si la personne est prête à arrêter de fumer ; aider la personne à élaborer un plan d'arrêt du tabac ; organiser un suivi. Les conseils doivent être adaptés ou personnalisés en fonction des circonstances individuelles.
- Tous les adultes souhaitant arrêter de fumer devraient se voir proposer des services d'aide au sevrage tabagique ou être orientés vers ceux-ci, comme le recommandent les lignes directrices existantes de l'OMS sur la prévention du tabagisme, la promotion du sevrage tabagique et le diagnostic et le traitement de la dépendance à l'égard du tabac.

Recommandation relative à la réduction des risques liés aux infections sexuellement transmissibles



Les couples et les personnes qui planifient une grossesse ou sont en recherche de grossesse et qui se rendent dans un établissement de soins de santé doivent être systématiquement informés des infections sexuellement transmissibles (IST), y compris du risque d'infertilité liée aux IST non traitées. Les couples et les individus doivent être encouragés à consulter rapidement et à se faire traiter s'ils présentent des symptômes d'IST. (*Énoncé de bonnes pratiques*)

Remarque :

- En cas de symptômes d'IST ou si une infection est confirmée, il existe des recommandations de l'OMS sur la prise en charge des IST.



Recommandations relatives au diagnostic de l'infertilité féminine

Recommandations relatives au diagnostic de l'infertilité liée à un dysfonctionnement ovulatoire



Pour les femmes ayant des problèmes d'infertilité mais présentant des résultats normaux à l'anamnèse (y compris des cycles menstruels réguliers) et à l'examen physique, l'OMS recommande de procéder à un diagnostic présomptif de l'ovulation en mesurant le taux sérique de progestérone au milieu de la phase lutéale plutôt qu'en effectuant une échographie. Pour les femmes chez qui le taux sérique de progestérone au milieu de la phase lutéale indique une absence d'ovulation, il est recommandé de répéter l'examen afin de réduire au minimum le risque de diagnostic incorrect d'anovulation. *(Recommandation soumise à conditions, degré de certitude des données probantes très faible)*

Remarques :

- Le taux sérique de progestérone au milieu de la phase lutéale est évalué environ 7 jours avant la date prévue des prochaines règles, mais il convient de noter que la date précise de début du cycle peut varier en fonction de la durée du cycle menstruel de chaque femme.
- Une nouvelle mesure du taux sérique de progestérone au milieu de la phase lutéale pourrait être effectuée au cours d'un cycle menstruel ultérieur, compte tenu du délai d'exécution des tests et des variations d'un cycle à l'autre.

Pour les femmes présentant des problèmes d'infertilité et une anovulation ou une oligo-ovulation présumée, il est recommandé de procéder à un dosage des hormones reproductives liées à l'axe hypothalamo-hypophyso-ovarien (HHO) (telles que l'hormone folliculostimulante [FSH] et l'hormone lutéinisante [LH] voire, dans certains tableaux cliniques, l'estradiol [E2] et la testostérone [T]). Des examens supplémentaires (par exemple, dosage de la thyroïdostimuline [TSH] ou de la prolactine [PRL]) peuvent également être indiqués en fonction du tableau clinique. Le choix des tests de diagnostic à réaliser doit être fondé sur les résultats cliniques issus d'une anamnèse et d'un examen physique complets, de façon à s'assurer que l'évaluation est systématique et rentable. *(Énoncé de bonnes pratiques)*

Pour les femmes présentant des problèmes d'infertilité chez lesquelles d'autres causes d'anovulation et d'oligo-ovulation ont été exclues, l'OMS recommande de réaliser un diagnostic de faible réserve ovarienne en se fondant sur l'âge plutôt que sur des tests de diagnostic. Si des tests de diagnostic de la réserve ovarienne sont effectués, l'OMS recommande le comptage des follicules antraux (AFC), le dosage de l'hormone antimüllérienne (AMH) ou le dosage de l'hormone folliculostimulante (FSH) au deuxième ou troisième jour du cycle. *(Recommandation soumise à conditions, degré de certitude des données probantes très faible)*

Recommandations relatives au diagnostic de l'infertilité liée à un dysfonctionnement ovulatoire (suite)



Remarques :

- L'âge est le facteur le plus important permettant de prédire la réserve ovarienne. Par conséquent, il est possible que la prescription d'un test de réserve ovarienne en plus de l'évaluation de l'âge ne permette pas d'améliorer considérablement la précision du diagnostic d'une faible réserve ovarienne (évaluée par une faible réponse à la stimulation). Il convient de noter que pour certains cas cliniques, par exemple en cas d'insuffisance ovarienne prématurée, l'âge peut ne pas être un indicateur fiable de la réserve ovarienne.
- Le choix du test d'évaluation de la réserve ovarienne à réaliser doit être fondé sur l'acceptabilité et la disponibilité des tests et les ressources disponibles dans le contexte local.

Recommandations relatives au diagnostic de l'infertilité liée à une affection des trompes de Fallope



Pour les femmes présentant des problèmes d'infertilité et une affection présumée des trompes de Fallope, l'OMS recommande de procéder soit à une hystérosalpingographie (HSG), soit à une hystérosalpingo-contraste-sonographie (HyCoSy) pour évaluer la perméabilité des trompes. *(Recommandation soumise à conditions, degré de certitude des données probantes faible)*

Remarque :

- Pour choisir entre une HSG et une HyCoSy pour évaluer la perméabilité des trompes, il convient de prendre en compte la faisabilité, la disponibilité de prestataires de soins de santé formés et le risque d'allergie.

Recommandation relative au diagnostic de l'infertilité liée à un trouble de la cavité utérine



Pour les femmes présentant des problèmes d'infertilité qui sont suspectées d'avoir un trouble de la cavité utérine, l'OMS recommande d'examiner la cavité utérine au moyen d'une sonohystérogaphie par perfusion saline (SIS) plutôt qu'une échographie tridimensionnelle (3D). *(Recommandation soumise à conditions, degré de certitude des données probantes faible)*

Remarque :

- Lorsque l'échographie 3D est disponible dans le cadre des ressources existantes, elle peut être l'option privilégiée.

Pour les femmes présentant des problèmes d'infertilité qui sont suspectées d'avoir un trouble de la cavité utérine, l'OMS recommande d'examiner la cavité utérine au moyen d'une échographie tridimensionnelle (3D) plutôt que d'une échographie bidimensionnelle (2D) lorsque les ressources sont disponibles. *(Recommandation soumise à conditions, degré de certitude des données probantes faible)*

Pour les femmes présentant des problèmes d'infertilité qui sont suspectées d'avoir un trouble de la cavité utérine, l'OMS recommande d'examiner la cavité utérine au moyen d'une sonohystérogaphie par perfusion saline (SIS) plutôt qu'une échographie bidimensionnelle (2D). *(Recommandation soumise à conditions, degré de certitude des données probantes faible)*

Recommandation relative au diagnostic de l'infertilité liée à un trouble de la cavité utérine (suite) →

Pour les femmes présentant des problèmes d'infertilité qui sont suspectées d'avoir un trouble de la cavité utérine, l'OMS recommande d'examiner la cavité utérine au moyen d'une sonohystérographie par perfusion saline (SIS) plutôt qu'une hystérosalpingographie (HSG). *(Recommandation soumise à conditions, degré de certitude des données probantes très faible)*

Remarque :

- Les prestataires de santé peuvent choisir d'avoir recours à une échographie 2D plutôt qu'à une HSG lorsque les ressources sont limitées. Pour les femmes dont l'échographie 2D est négative mais qui sont tout de même suspectées d'avoir un trouble de la cavité utérine, il convient de réaliser des examens complémentaires en raison du taux élevé de faux négatifs.



Recommandations relatives au diagnostic de l'infertilité masculine

Recommandation relative à l'analyse du sperme



Pour les hommes (dans les couples infertiles) présentant un ou plusieurs paramètres spermatiques en dehors des plages de référence de l'OMS, l'OMS recommande de répéter l'analyse de sperme après un délai minimum de 11 semaines. *(Recommandation soumise à conditions, degré de certitude des données probantes très faible)*

Pour les hommes (dans les couples infertiles) dont tous les paramètres spermatiques se situent dans les plages de référence de l'OMS, l'OMS recommande de ne pas répéter l'analyse du sperme. *(Recommandation soumise à conditions, degré de certitude des données probantes très faible)*

Remarque :

- La dernière version du manuel de laboratoire de l'OMS pour l'examen et le traitement du sperme humain fournit des plages de référence de l'OMS pour les paramètres spermatiques ainsi que des informations détaillées sur les procédures normalisées de collecte et d'analyse du sperme.



Recommandations relatives au diagnostic de l'infertilité inexpliquée

L'OMS recommande de poser un diagnostic d'infertilité inexpliquée chez un couple lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :

- incapacité à obtenir une grossesse après 12 mois de rapports sexuels réguliers non protégés ;
- examen physique et antécédents médicaux normaux chez l'homme et la femme ;
- confirmation présumée de l'ovulation et des trompes de Fallope perméables chez la femme ;
- paramètres spermatiques se situant dans les plages de référence de l'OMS chez l'homme.

(Recommandation soumise à conditions, degré de certitude des données probantes très faible)



Recommandations relatives au traitement de l'infertilité féminine

Recommandations relatives au traitement de l'infertilité liée à un dysfonctionnement ovulatoire



Pour les femmes présentant des problèmes d'infertilité liés à un dysfonctionnement ovulatoire causé par le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK), l'OMS recommande d'avoir recours au létrozole plutôt qu'au citrate de clomifène ou à la metformine. Il est recommandé d'utiliser du létrozole seul plutôt qu'en combinaison avec de la metformine.
(Recommandation soumise à conditions, degré de certitude des données probantes faible concernant l'utilité du létrozole par rapport au citrate de clomifène, et degré de certitude des données probantes faible concernant l'utilité du létrozole seul par rapport à de la metformine seule, et degré de certitude des données probantes très faible concernant l'utilité du létrozole seul par rapport au létrozole en combinaison avec de la metformine)

Lorsque l'usage hors indication du létrozole n'est pas autorisé, l'utilisation de citrate de clomifène en combinaison avec de la metformine plutôt que du citrate de clomifène seul ou de la metformine seule est recommandée.
(Recommandation soumise à conditions, degré de certitude modéré des données probantes concernant l'utilité du citrate de clomifène seul par rapport au citrate de clomifène combiné à de la metformine, et degré de certitude très faible des données probantes concernant l'utilité du citrate de clomifène par rapport à la metformine)

Recommandations relatives au traitement de l'infertilité liée à un dysfonctionnement ovulatoire (suite)



Dans le cadre de la prise en charge du syndrome des ovaires polykystiques (SOPK), il est recommandé de fournir des conseils aux patientes concernant les changements de mode de vie à adopter, tels qu'une alimentation saine, une activité physique régulière ou la maîtrise du poids. (*Énoncé de bonnes pratiques*)

Pour les femmes présentant des problèmes d'infertilité liés à un dysfonctionnement ovulatoire causé par le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) et qui n'ont pas obtenu de résultats satisfaisants avec un traitement pharmacologique par voie orale, tel que la prise de létrozole ou de citrate de clomifène en combinaison avec de la metformine, l'OMS recommande d'avoir recours aux gonadotrophines plutôt qu'au drilling ovarien par coelioscopie. (*Recommandation soumise à conditions, degré de certitude des données probantes faible*)

Pour les femmes présentant des problèmes d'infertilité liés à un dysfonctionnement ovulatoire causé par le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) et qui n'ont pas obtenu de résultats satisfaisants avec un traitement pharmacologique par voie orale, tel que la prise de létrozole, de citrate de clomifène en combinaison avec de la metformine ou de gonadotrophines, l'OMS recommande d'avoir recours à la fécondation in vitro (FIV) plutôt qu'à la prise en charge expectative. (*Recommandation soumise à conditions, degré de certitude des données probantes très faible*)

Pour les femmes présentant des problèmes d'infertilité liés à un dysfonctionnement ovulatoire causé par une hyperprolactinémie, l'OMS recommande d'avoir recours à la cabergoline plutôt qu'à la bromocriptine. (*Recommandation soumise à conditions, degré de certitude des données probantes faible*)

Recommandations relatives au traitement de l'infertilité liée à une affection des trompes de Fallope



Pour les femmes âgées de moins de 35 ans atteintes d'une affection des trompes de Fallope légère à modérée (niveaux I et II selon la classification de Hull et Rutherford), l'OMS recommande d'avoir recours à la chirurgie plutôt qu'à la fécondation in vitro (FIV). (*Recommandation soumise à conditions, degré de certitude des données probantes très faible*)

Remarques :

- Après la chirurgie, il convient d'attendre au moins un an avant d'envisager d'autres interventions, telles que la FIV, pour tenter d'obtenir une grossesse.
- Cette recommandation ne s'applique pas aux femmes ayant subi précédemment une ligature des trompes.

Recommandations relatives au traitement de l'infertilité liée à une affection des trompes de Fallope (suite) ➔

Pour les femmes âgées de moins de 35 ans atteintes d'une affection des trompes de Fallope grave (niveau III selon la classification de Hull et Rutherford), l'OMS recommande d'avoir recours à la fécondation in vitro (FIV) plutôt qu'à la chirurgie. *(Recommandation soumise à conditions, degré de certitude des données probantes très faible)*

Remarque :

- Cette recommandation ne s'applique pas aux femmes ayant subi précédemment une ligature des trompes.

Pour les femmes âgées de 35 ans ou plus atteintes d'une affection des trompes de quelque niveau que ce soit, l'OMS recommande d'avoir recours à la fécondation in vitro (FIV) plutôt qu'à la chirurgie. *(Recommandation soumise à conditions, degré de certitude des données probantes très faible)*

Pour les femmes présentant des problèmes d'infertilité liés aux trompes de Fallope causés par un hydrosalpinx, l'OMS recommande d'avoir recours soit à une salpingectomie, soit à une occlusion tubaire avant une fécondation in vitro (FIV). *(Recommandation soumise à conditions, degré de certitude des données probantes très faible)*

Remarque :

- Pour choisir entre la salpingectomie et l'occlusion tubaire, il convient de tenir compte de la faisabilité, de la disponibilité de prestataires de santé formés et de la présence d'amas de tissus.

Pour les femmes présentant des problèmes d'infertilité liés aux trompes de Fallope causés par un hydrosalpinx, l'OMS recommande d'avoir recours soit à une salpingectomie, soit à une occlusion tubaire plutôt qu'à une aspiration transvaginale du liquide d'hydrosalpinx avant la fécondation in vitro (FIV). *(Recommandation soumise à conditions, degré de certitude des données probantes très faible)*

Remarque :

- Lorsque la salpingectomie et l'occlusion tubaire ne sont pas disponibles ou réalisables, l'aspiration transvaginale peut être proposée.

Recommandations relatives au traitement de l'infertilité liée à un trouble de la cavité utérine ➔

Pour les femmes présentant des problèmes d'infertilité et un utérus cloisonné qui n'ont pas d'antécédents de fausses couches à répétition, l'OMS recommande de ne pas pratiquer de résection hystéroscopique du septum (septoplastie hystéroscopique). *(Recommandation soumise à conditions, degré de certitude des données probantes faible)*



Recommandations relatives au traitement de l'infertilité masculine

Recommandation relative à l'utilisation d'antioxydants →

Pour les hommes présentant des problèmes d'infertilité et un ou plusieurs paramètres spermatiques en dehors des plages de référence de l'OMS et qui tentent d'obtenir une grossesse avec ou sans procréation médicalement assistée, le groupe d'élaboration des lignes directrices de l'OMS sur l'infertilité n'a pas formulé de recommandation se prononçant pour ou contre l'utilisation d'antioxydants.

Remarque :

- Une nutrition optimale est importante pendant la période précédant la grossesse pour le couple ; toutefois, les effets des compléments alimentaires antioxydants pour les hommes atteints de pathologies spécifiques chez les couples infertiles ne sont actuellement pas connus.

Recommandations relatives au traitement de la varicocèle →

Pour les hommes présentant des problèmes d'infertilité et une varicocèle clinique, l'OMS recommande d'avoir recours à un traitement chirurgical ou radiologique plutôt qu'à une prise en charge expectative. (*Recommandation soumise à conditions, degré de certitude des données probantes faible*)

Remarques :

- Les hommes présentant une varicocèle clinique et des paramètres spermatiques en dehors des plages de référence de l'OMS ont plus de chances d'obtenir des résultats positifs au traitement contre la varicocèle que les hommes dont les paramètres spermatiques se situent dans les plages de référence de l'OMS.
- Cette recommandation s'applique aux hommes atteints de varicocèle chez les couples infertiles qui ne suivent pas de traitement dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation (AMP).

Pour les hommes présentant des problèmes d'infertilité qui suivent un traitement contre la varicocèle, l'OMS recommande d'avoir recours à un traitement chirurgical ou radiologique. (*Recommandation soumise à conditions, degré de certitude des données probantes très faible*)

Remarques :

- Pour choisir entre un traitement chirurgical ou radiologique, il convient de tenir compte de la faisabilité, de la disponibilité de prestataires de soins de santé formés et des préférences du patient concernant le type de traitement.
- Cette recommandation s'applique aux hommes atteints de varicocèle chez les couples infertiles qui ne suivent pas de traitement dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation (AMP).

Recommandations relatives au traitement de la varicocèle (suite)



Pour les hommes présentant des problèmes d'infertilité qui suivent un traitement chirurgical de la varicocèle, l'OMS recommande d'avoir recours à la chirurgie microscopique plutôt qu'à d'autres actes chirurgicaux.

(Recommandation soumise à conditions, degré de certitude des données probantes très faible)

Remarques :

- La microchirurgie sous-inguinale est une forme courante de varicocélectomie, mais il existe également d'autres actes chirurgicaux utilisant une approche ouverte non microscopique (tels que la chirurgie inguinale et la chirurgie rétropéritonéale) et des techniques laparoscopiques.
- Lorsque l'expertise nécessaire pour effectuer une chirurgie microscopique n'est pas disponible, d'autres techniques chirurgicales peuvent être utilisées.
- Cette recommandation s'applique aux hommes atteints de varicocèle chez les couples infertiles qui ne suivent pas de traitement dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation (AMP).

Pour les hommes présentant des problèmes d'infertilité qui subissent un traitement chirurgical non microscopique de la varicocèle, l'OMS recommande d'avoir recours à la chirurgie inguinale ou rétropéritonéale.

(Recommandation soumise à conditions, degré de certitude des données probantes très faible)

Remarques :

- Pour choisir entre la chirurgie inguinale ou rétropéritonéale, il convient de tenir compte de la faisabilité et de la disponibilité de prestataires de soins de santé formés.
- Cette recommandation s'applique aux hommes atteints de varicocèle chez les couples infertiles qui ne suivent pas de traitement dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation (AMP).



Recommandations relatives au traitement de l'infertilité inexpliquée

Recommandations relatives à la prise en charge de première ligne des couples présentant une infertilité inexpliquée



Pour les couples présentant une infertilité inexpliquée, l'OMS recommande une prise en charge expectative plutôt qu'une insémination intra-utérine (IIU) sans stimulation ovarienne. *(Recommandation soumise à conditions, degré de certitude des données probantes faible)*

Remarques :

- La prise en charge expectative consiste à suivre le couple dans l'attente que la grossesse sera obtenue sans intervention médicale. Il s'agit notamment de fournir des conseils sur le mode de vie et les jours les plus fertiles du cycle menstruel, et de surveiller si une grossesse se produit, sans aucune intervention médicale.
- La durée de la prise en charge expectative est généralement de 3 à 6 mois selon les études sur lesquelles repose cette recommandation.

Pour les couples présentant une infertilité inexpliquée, l'OMS recommande une prise en charge expectative plutôt qu'une stimulation ovarienne avec des rapports sexuels programmés. *(Recommandation soumise à conditions, degré de certitude des données probantes faible)*

Remarques :

- La prise en charge expectative consiste à suivre le couple dans l'attente que la grossesse sera obtenue sans intervention médicale. Il s'agit notamment de fournir des conseils sur le mode de vie et les jours les plus fertiles du cycle menstruel, et de surveiller si une grossesse se produit, sans aucune intervention médicale.
- La durée de la prise en charge expectative est généralement de 3 à 6 mois selon les études sur lesquelles repose cette recommandation.

Recommandations relatives à la prise en charge de deuxième ligne des couples présentant une infertilité inexplicée



Pour les couples présentant une infertilité inexplicée pour lesquels la prise en charge expectative n'a pas abouti, l'OMS recommande d'avoir recours à l'insémination intra-utérine (IIU) avec stimulation ovarienne en utilisant soit du citrate de clomifène, soit du létrozole. *(Recommandation soumise à conditions, degré de certitude des données probantes faible)*

Remarques :

- Pour choisir entre le citrate de clomifène et le létrozole, il convient de tenir compte de la législation et de la réglementation nationales applicables relatives à l'usage hors indication du létrozole.
- Le nombre optimal de cycles d'insémination intra-utérine (IIU) avec stimulation ovarienne est inconnu. Dans les études sur lesquelles s'appuie cette recommandation, différents nombres de cycles sont évoqués, allant de un à six, les études les plus récentes recommandant trois à six cycles.

Pour les couples présentant une infertilité inexplicée pour lesquels la prise en charge expectative n'a pas abouti, l'OMS recommande d'avoir recours à l'insémination intra-utérine (IIU) avec stimulation ovarienne en utilisant du citrate de clomifène ou du létrozole plutôt que des gonadotrophines. *(Recommandation soumise à conditions, degré de certitude des données probantes très faible)*

Remarque :

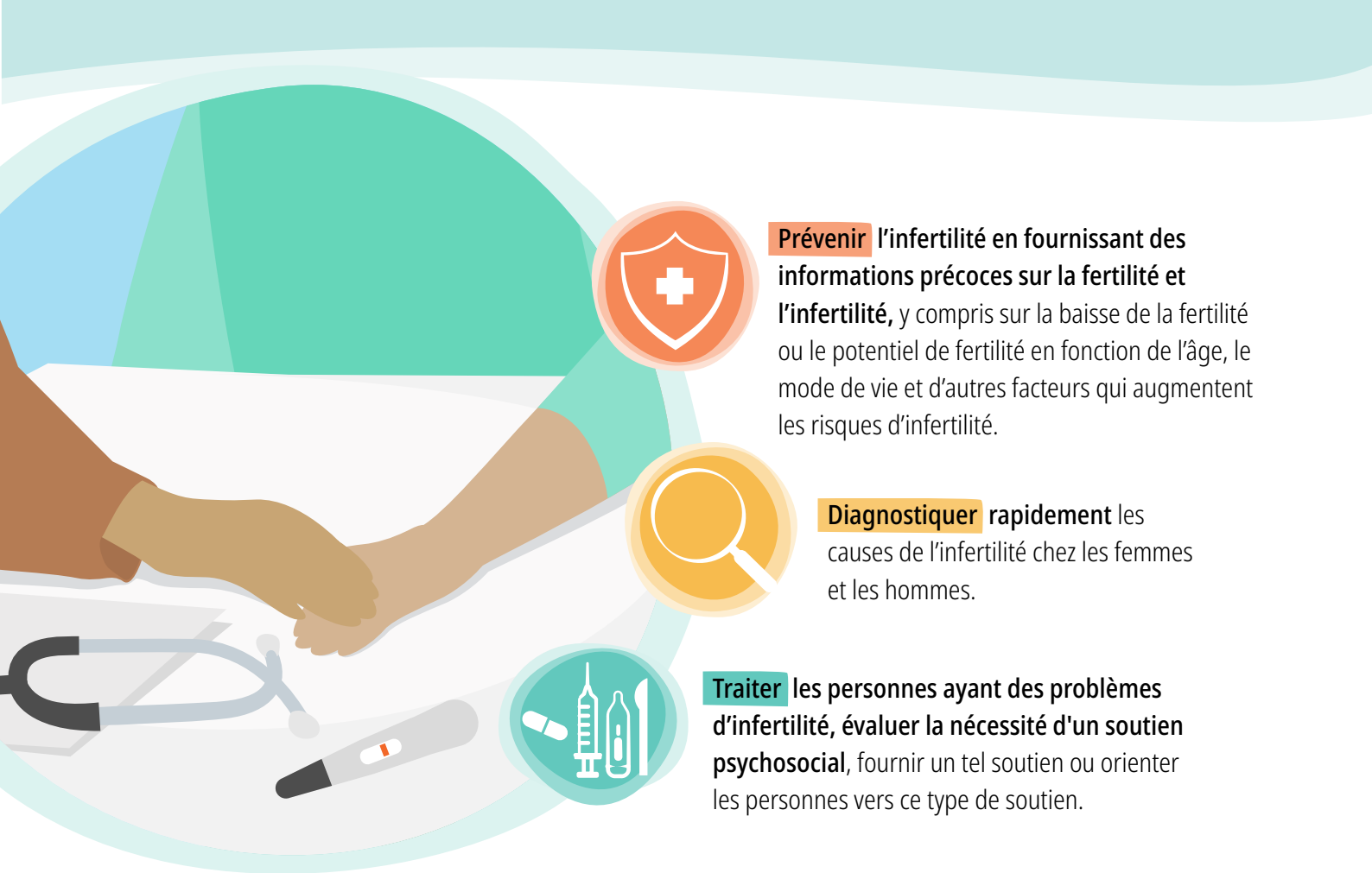
- Le nombre optimal de cycles d'insémination intra-utérine (IIU) avec stimulation ovarienne est inconnu. Dans les études sur lesquelles s'appuie cette recommandation, différents nombres de cycles sont évoqués, allant de un à six, les études les plus récentes recommandant trois à six cycles.

Recommandations relatives à la prise en charge de troisième ligne de l'infertilité inexplicée



Pour les couples présentant une infertilité inexplicée pour lesquels l'insémination intra-utérine (IIU) avec stimulation ovarienne n'a pas abouti, l'OMS recommande d'avoir recours à la fécondation in vitro (FIV) plutôt qu'à la prise en charge expectative. *(Recommandation soumise à conditions, degré de certitude des données probantes faible)*

Pour les couples présentant une infertilité inexplicée qui entreprennent une fécondation in vitro (FIV) après une insémination intra-utérine (IIU) avec stimulation ovarienne qui n'a pas abouti, l'OMS recommande d'avoir recours à la FIV seule plutôt qu'à la FIV avec injection intracytoplasmique de spermatozoïde (ICSI). *(Recommandation forte, degré de certitude des données probantes faible)*



Prévenir l'infertilité en fournissant des informations précoces sur la fertilité et l'infertilité, y compris sur la baisse de la fertilité ou le potentiel de fertilité en fonction de l'âge, le mode de vie et d'autres facteurs qui augmentent les risques d'infertilité.

Diagnostiquer rapidement les causes de l'infertilité chez les femmes et les hommes.

Traiter les personnes ayant des problèmes d'infertilité, évaluer la nécessité d'un soutien psychosocial, fournir un tel soutien ou orienter les personnes vers ce type de soutien.



Adaptation des recommandations formulées dans les lignes directrices

Les pays devraient adapter les recommandations à leurs besoins nationaux, en fonction du contexte local, en ayant recours à la mobilisation inclusive de tous les partenaires locaux, y compris les autorités nationales et infranationales, la société civile, les organisations de patients et les sociétés professionnelles de divers prestataires de soins de santé intervenant dans le domaine de la fertilité. L'adaptation nationale devrait être fondée sur le profil épidémiologique du pays en fonction de la charge d'infertilité et de l'évaluation des besoins, et tenir compte de l'organisation et de la capacité du système de soins de santé, des ressources nécessaires, ainsi que des contextes sanitaire, social, culturel et économique locaux.



Mise en œuvre des recommandations formulées dans les lignes directrices

La mise en œuvre réussie des recommandations contenues dans les lignes directrices nécessitera le soutien de multiples parties prenantes au niveau national, notamment les ministères de la santé, les sociétés professionnelles locales, les organisations non gouvernementales, la société civile et les groupes de patients. Pour une utilisation efficace de ces recommandations, il est essentiel que les systèmes de santé au niveau national créent un environnement favorable à la la prévention, au diagnostic et au traitement de l'infertilité. Il peut s'agir, par exemple, de s'assurer que la question de l'infertilité est prise en compte dans les ministères concernés, les politiques de santé et autres (par exemple, les politiques éducatives ou sociales), les plans stratégiques, les services et les financements, ainsi que d'inclure des médicaments pour la fertilité dans les listes de médicaments essentiels, de former des professionnels de la santé à l'infertilité, de modifier les systèmes d'information sanitaire pour intégrer des données sur l'infertilité et d'élaborer de recommandations cliniques nationales sur l'infertilité.



Suivi et évaluation des recommandations formulées dans les lignes directrices

Le suivi et l'évaluation doivent être intégrés dans

le processus de mise en œuvre de façon à tenir compte des enseignements tirés pour améliorer continuellement la mise en œuvre. La mise en œuvre des recommandations doit comprendre la collecte et la communication de données par les programmes nationaux (et les partenaires concernés) sur les services fournis pour prévenir, diagnostiquer ou traiter l'infertilité. Pour ce faire, il pourrait être nécessaire de revoir les systèmes d'information sanitaire existants, notamment les registres de l'assistance médicale à la procréation (AMP), les dossiers médicaux électroniques et autres systèmes électroniques de données des patients et d'enregistrement des données d'état civil, afin de s'assurer que les données relatives à la prestation de services sont recueillies

et communiquées de manière adéquate. Certains indicateurs pouvant être utilisés pour suivre les progrès réalisés peuvent déjà être disponibles dans les systèmes d'information sanitaire existants, les systèmes nationaux de surveillance ou les registres de l'AMP ; pour d'autres, des enquêtes ou des évaluations périodiques peuvent être nécessaires. Un soutien politique est essentiel, de même qu'il est indispensable de mettre en place une approche fondée sur les droits en matière de reproduction lors de la mise en œuvre. La prestation de soins en matière de fertilité ne doit pas être fondée sur les taux de fécondité globale. Il convient d'encourager la recherche sur la mise en œuvre afin de faciliter l'adaptation, la mise en œuvre et l'amélioration continue de la qualité des lignes directrices.



Portée future et mise à jour des recommandations formulées dans les lignes directrices

Les *Lignes directrices de l'OMS sur la prévention, le diagnostic et*

le traitement de l'infertilité ne couvrent pas tous les aspects liés à l'infertilité. Des versions ultérieures devraient venir élargir la portée de ces lignes directrices et fournir des recommandations sur des sujets qui ne sont pas abordés actuellement, tels que la prise en charge d'autres facteurs de risque personnels (tels que l'obésité, le faible poids corporel, la consommation excessive d'alcool et d'autres substances, y compris l'utilisation de produits de vapotage contenant du cannabis et de cigarettes électroniques ou de produits du tabac non fumés ou sans fumée, entre autres), ainsi que de facteurs de risque non personnels (par exemple, liés à l'environnement ou au travail), les troubles sexuels, la préservation de la fertilité dans le cadre de thérapies gonadotoxiques, la procréation avec tiers

donneur (don de gamètes ou gestation pour autrui), les soins de fertilité pour les personnes vivant avec des affections médicales préexistantes ayant une incidence sur la fertilité (comme l'endométriose et les fibromes), ou présentant des anomalies obstructives, congénitales, génitales, hormonales ou des glandes accessoires associées à l'infertilité masculine, ainsi que la fourniture d'un soutien psychosocial aux personnes ayant des problèmes d'infertilité. Des orientations élargies sur le diagnostic avancé et les modalités de traitement de l'infertilité masculine doivent également être élaborées. De nouvelles interventions expérimentales sur l'infertilité font leur apparition, notamment l'utilisation de l'intelligence artificielle, des technologies des équipements et des traitements médicaux. L'OMS suivra ces évolutions, entre autres, pour éventuellement les prendre en compte lors des mises à jour ultérieures des lignes directrices.

Références bibliographiques

1. Lignes directrices de l'OMS sur la prévention, le diagnostic et le traitement de l'infertilité. Genève ; Organisation mondiale de la Santé ; 2025. [à venir].
2. Organisation mondiale de la Santé. Manuel de l'OMS pour l'élaboration de lignes directrices, 2e éd. Genève : Organisation mondiale de la Santé, 2014 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/145714>).

Remerciements

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et le Programme spécial PNUD/FNUAP/UNICEF/OMS/Banque mondiale de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine remercient avec gratitude les nombreuses personnes et organisations qui ont contribué à l'élaboration des présentes orientations. Nous remercions sincèrement le groupe d'élaboration des lignes directrices, le Groupe d'examen externe, l'équipe chargée de la synthèse des éléments probants, le méthodologiste des lignes directrices, le Groupe d'orientation sur les lignes directrices, les consultants et le Comité d'examen des lignes directrices. Le processus global d'élaboration de ces lignes directrices a été mené par Gitau Mburu, avec le soutien de James Kiarie et Pascale Allotey. On trouvera la liste complète des remerciements dans la version intégrale des lignes directrices.

Financement

Le présent document a été financé par le Programme spécial PNUD/FNUAP/UNICEF/OMS/Banque mondiale de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine, un programme coparrainé mis en œuvre par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

© **Organisation mondiale de la Santé 2025**. Certains droits réservés. La présente publication est disponible sous la licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Citation suggérée. Lignes directrices sur la prévention, le diagnostic et le traitement de l'infertilité : résumé des recommandations [Guideline for the prevention, diagnosis and treatment of infertility: summary of recommendations]. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2025. <https://doi.org/10.2471/B09632>



Pour plus d'informations, veuillez contacter :

**Département Santé sexuelle et reproductive, santé de
la mère, de l'enfant et de l'adolescent et vieillissement**

Programme spécial de recherche, de développement et de
formation à la recherche en reproduction humaine (HRP) de
l'Organisation mondiale de la Santé

20 avenue Appia
CH-1211 Genève 27
Suisse

Courriel : srhcfrc@who.int
<https://www.who.int/health-topics/infertility>